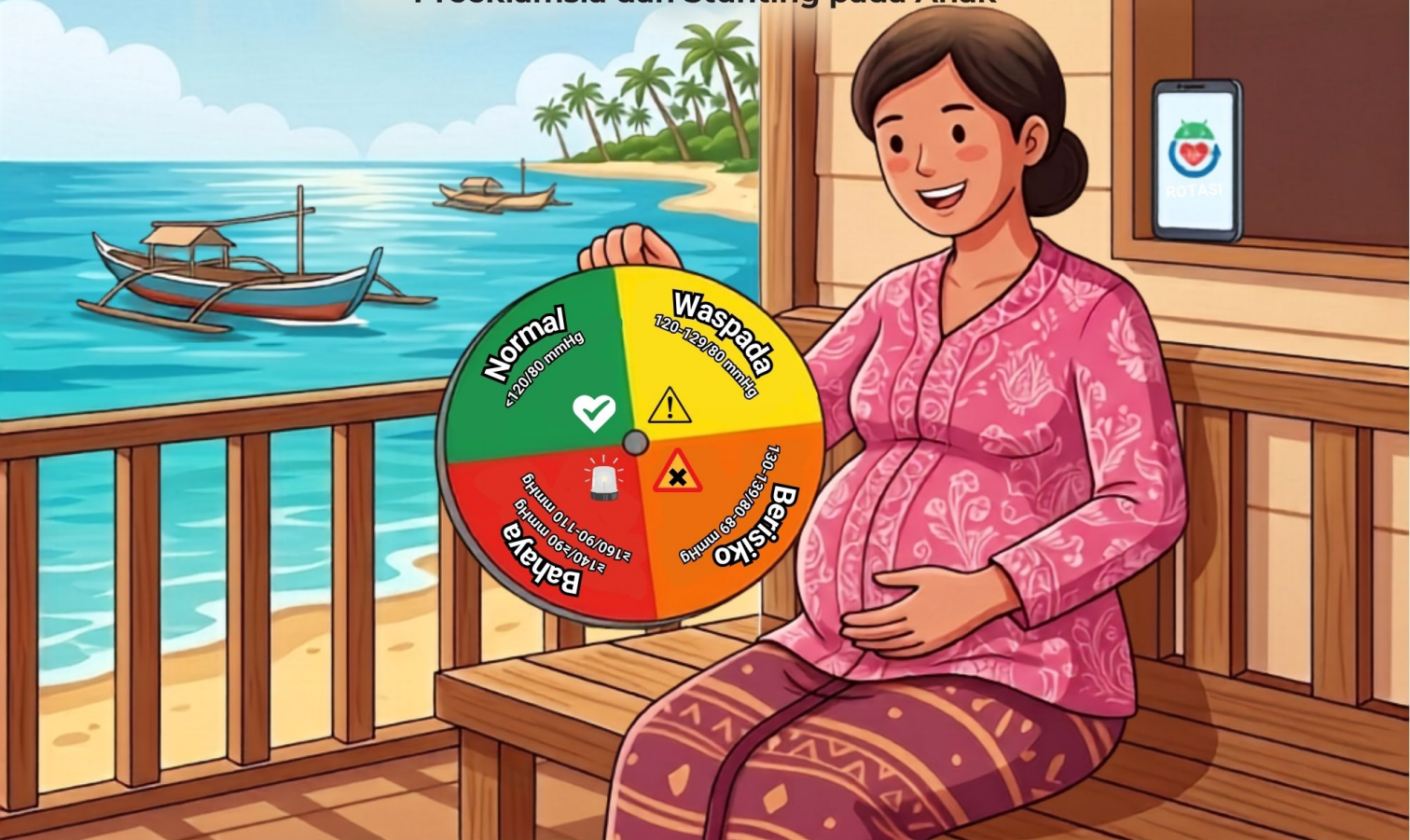




Puskesmas Barombong

ROTASI RODA PANTAU TENSI

Panduan Praktis Ibu Hamil Pesisir Mencegah
Preeklamsia dan Stunting pada Anak



Tim Pengusul Riset Hibah BIMA 2026: Serli, M.Kes, Sitti Mawaddah Umar, M.Kom, Rasdiana R, M.Kes, Serli, Nurfaida
Didanai oleh: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia

KATA PENGANTAR

Booklet Hibrid ROTASI menghadirkan inovasi pemantauan mandiri tekanan darah di rumah (Home Blood Pressure Monitoring/HBPM) terpadu tenaga kesehatan melalui integrasi alat fisik roda putar dan aplikasi Android. Fokus intervensi diarahkan pada sektor hulu kehamilan di wilayah pesisir sebagai upaya strategis pencegahan stunting sejak dini.

Inisiatif ini merupakan wujud nyata kontribusi dalam menyukseskan Sustainable Development Goal (SDG) 3.2, yaitu mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah pada tahun 2030. Selain itu, program ini sejalan dengan Asta Cita 4 untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), kesehatan, serta sains dan teknologi.

Booklet ini dirancang interaktif untuk menghubungkan hasil tensi petugas kesehatan dengan langkah nyata menjaga masa depan sang buah hati.

Tim Riset ROTASI



DAFTAR ISI



Periode EMAS 1000 HPK



Mengenal "Musuh" & Tanda Bahaya Kehamilan



Cara Kerja Hibrid ROTASI (Roda & Aplikasi)



Status HIPOTENSI (<90/60 mmHg)



Status NORMAL (<120/<80 mmHg)



Status WASPADA (120-129/<80 mmHg)



Status BERISIKO (130-139/80-89 mmHg)



Status BAHAYA (>140/>90 mmHg)



Status DARURAT (>160/110 mmHg)



Masa Nifas & Kesehatan Jiwa Ibu



Menjaga Jantung & Ginjal Seumur Hidup



Logbook Pemantauan ANC

PERIODE EMAS

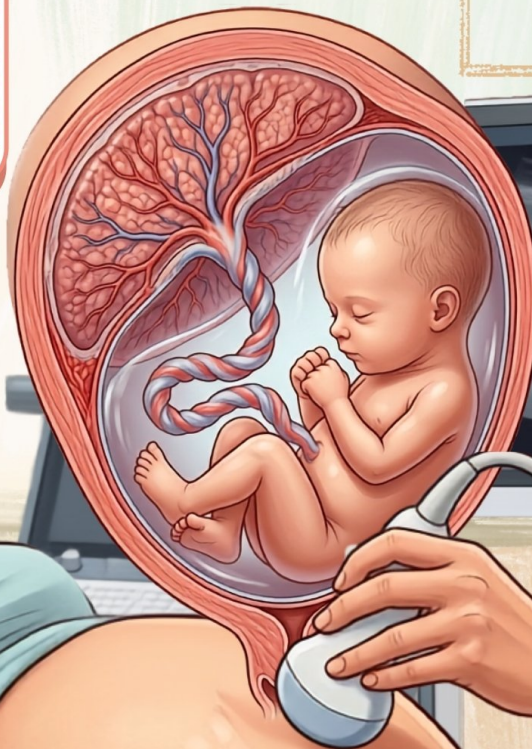
1000 HPK

APA ITU
1000 HPK ?

1000 Hari Pertama Kehidupan dihitung sejak 270 hari (9 bulan) dalam kandungan hingga 730 hari (2 tahun pertama) kehidupan anak.

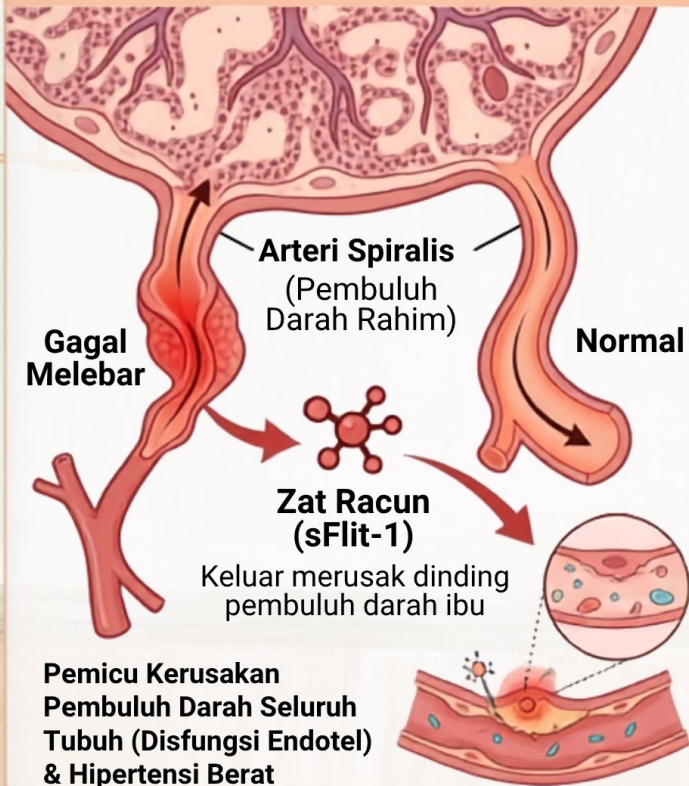
Mengapa Sangat Penting?

Organ vital (jantung, paru, ginjal) dan miliaran sambungan saraf otak anak dibentuk pada periode ini. Kerusakan gizi pada masa emas ini bersifat permanen dan tidak dapat diperbaiki saat anak dewasa.

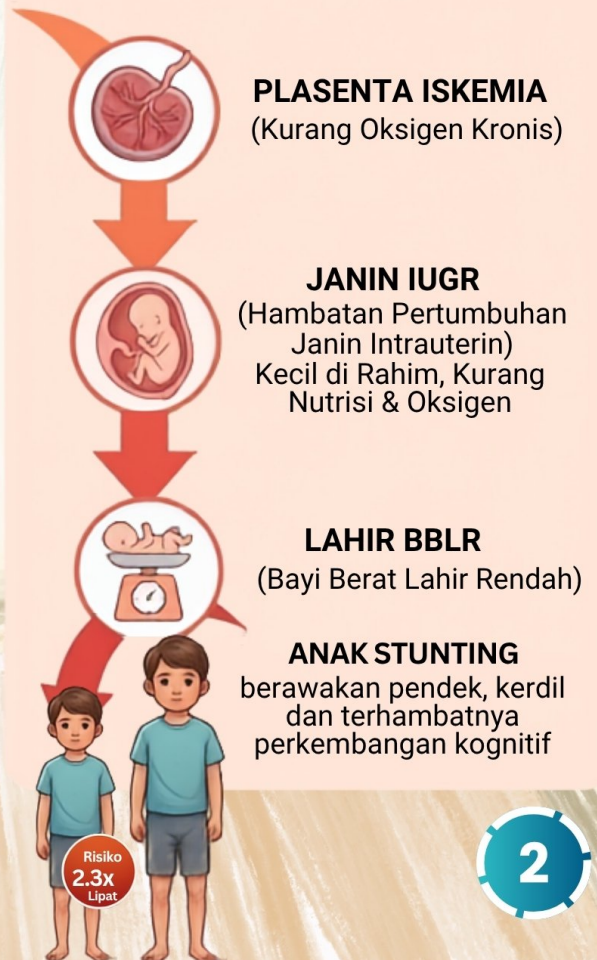


HUBUNGAN PREEKLAMPSIA DAN STUNTING

BERAWAL DARI PREEKLAMPSIA (Maladaptasi Plasenta)



BERAKHIR DI STUNTING



MENGENAL

Hipertensi, Preeklamsia, & Eklamsia

Hipertensi Gestasional



Tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg dan/atau diastolik ≥ 90 mmHg setelah usia kehamilan 20 minggu, tanpa disertai proteinuria.

Preeklamsia



Preeklamsia Hipertensi disertai proteinuria positif (protein dalam urine) atau disfungsi organ lain (seperti ginjal, hati, atau hematologi).

Eklamsia



Eklamsia Preeklamsia berat yang memicu timbulnya kejang-kejang mendadak dan/atau penurunan kesadaran, mengancam nyawa ibu dan janin.

5 TANDA BAHAYA WAJIB SEGERA KE BIDAN



SAKIT KEPALA

Sakit kepala berat yang tidak hilang dengan istirahat.



MATA BERBAYANG

Pandangan mata mendadak kabur, berkunang-kunang, atau peka cahaya.



ULU HATI TERBAKAR

Nyeri menusuk di ulu hati / perut kana atas (bukan sakit maag biasa).



WAJAH & TANGAN BENGKAK MENDADAK.

Mual dan muntah hebat di trimester 2 atau 3.



JANIN BERHENTI MENENDANG

Gerakan janin berkurang (kurang dari 10 kali dalam 12 jam)

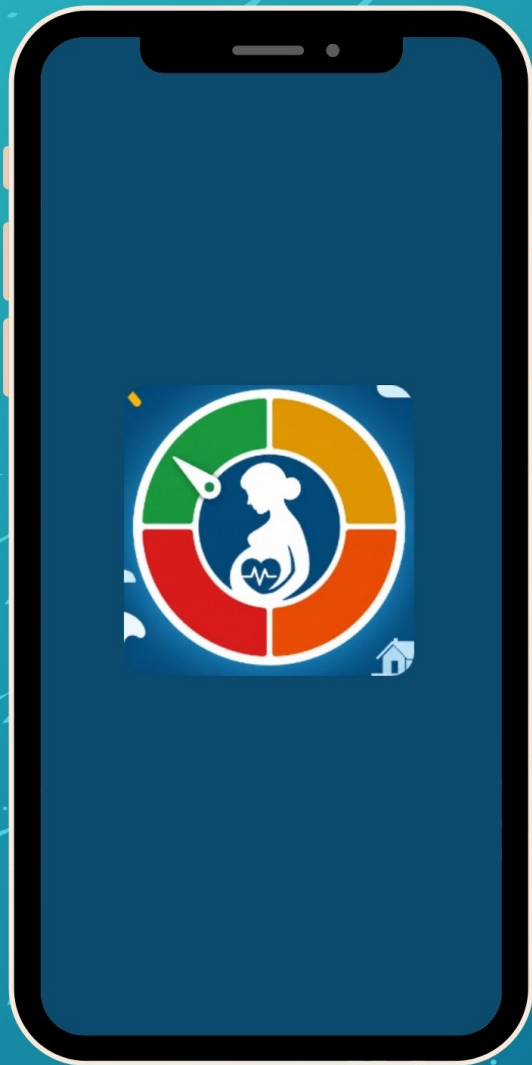


WASPADAI TANDA-TANDA INI:
JIKA MERASAKAN SALAH SATU TANDA DI ATAS,
JANGAN TUNDA! SEGERA KE PUSKESMAS/RS.



APLIKASI PENDAMPING DIGITAL

ROTASI



SCAN
ME!



Scan QR Code

Scan QR Code untuk mengunduh ROTASI App.



Instal Aplikasi

Instal ROTASI App di smartphone Anda.



Lengkapi Data Diri

Masukkan biodata diri dan hasil pengukuran tekanan darah terakhir.



Cek Status Tekanan Darah

Gunakan fitur ROTASI untuk mengetahui status tekanan darah Ibu dengan mudah dan cepat.

STATUS

TEKANAN DARAH RENDAH

Hipotensi

(Tekanan Darah Rendah)

Tekanan darah Ibu terlalu rendah ($-90/60$ mmHg). Aliran darah ke janin mungkin melambat, membuat Ibu pusing atau pingsan.

Gejala Umum: Pusing saat bangun mendadak, pandangan berkunang-kunang, lemas, mual.

PANDUAN AKSI HIPOTENSI

Langkah Aksi Segera:



Cukupkan Cairan

Minum air putih lebih banyak
(minimal 2,5 – 3 liter/hari).



Ubah Posisi Perlahan

Jangan bangun mendadak
dari posisi tidur/duduk.



Nutrisi Seimbang

Konsumsi makanan bergizi,
vitamin B12 dan asam folat, telur
ayam, daging tanpa lemak, bayam
dan brokoli, buah alpukat, dll.



Tidur Miring Kiri

Optimalkan aliran darah ke
plasenta.

**“Jika Ibu sering pingsan atau
pusing hebat, segera
konsultasikan ke Bidan terdekat.”**

STATUS TEKANAN DARAH

Normal

Tekanan Darah $<120 / <80$ mmHg



Artinya

Aliran darah dan pasokan nutrisi ke plasenta berjalan sangat lancar. Janin menerima asupan sempurna untuk pembentukan otak dan organ tubuh.

Target Ibu

Pertahankan kondisi prima ini hingga hari persalinan dengan disiplin kontrol berkala

Gizi Pesisir Cegah Stunting



Konsumsi protein hewani segar (ikan laut segar, telur, ayam, udang) setiap hari. Ikan laut kaya DHA/ Omega-3 yang mencerdaskan janin.

Minum Tablet Tambah Darah (TTD) 1 tablet setiap malam dengan air putih (hindari teh/kopi/susu).

Lakukan aktivitas fisik ringan seperti jalan pagi di tepi pantai selama 30 menit.

Patuhi jadwal minimal 6 kali kunjungan ANC di Puskesmas.

WASPADA

120–129 / <80 mmHg)

Tekanan darah mulai merangkak naik melebihi batas ideal.
Pembuluh darah mengalami ketegangan awal.



“

Jangan panik! Ini adalah waktu terbaik untuk melakukan perbaikan gaya hidup sebelum berkembang menjadi preeklamsia.

”

Diet DASH Pesisir & Relaksasi

Strategi Pola Hidup Sehat Ibu Hamil Pesisir



Batas Garam & Penyedap

Hindari ikan asin, vetsin, camilan asin kemasan, dan kecap manis berlebih.



Pilih Makanan Segar

Perbanyak buah & sayur kalium tinggi (pisang, air kelapa), dan pilih olahan ikan kuah segar (misal: pallumara, kapurung, gado-gado)

“

Penerapan Diet DASH Rendah Natrium

Batasi garam dapur maksimal 1 sendok teh per hari. Hindari makanan berpengawet, kalengan, dan bumbu instan. Perbanyak asupan kalium dari buah dan sayur segar untuk membantu menstabilkan tekanan darah.

”



“

Teknik Relaksasi Napas Lambat (Slow Breathing):

Tarik napas dalam 4 detik - tahan 2 detik - buang perlahan 6 detik. Lakukan 15 menit **setiap pagi** untuk melonggarkan pembuluh darah dan mengurangi ketegangan.

”

BERISIKO (130–139) mmHg



Ibu telah masuk kategori hipertensi tahap awal.
Plasenta mulai berisiko mengalami penurunan suplai darah dan nutrisi.

Langkah Wajib Ibu:



Kurangi Aktivitas Berat

Hentikan mengangkat beban, mencuci berat, atau aktivitas fisik yang melelahkan.



Tidur Posisi Miring Kiri

Posisi ini meringankan beban pembuluh darah besar perut sehingga aliran darah ke janin tetap maksimal.



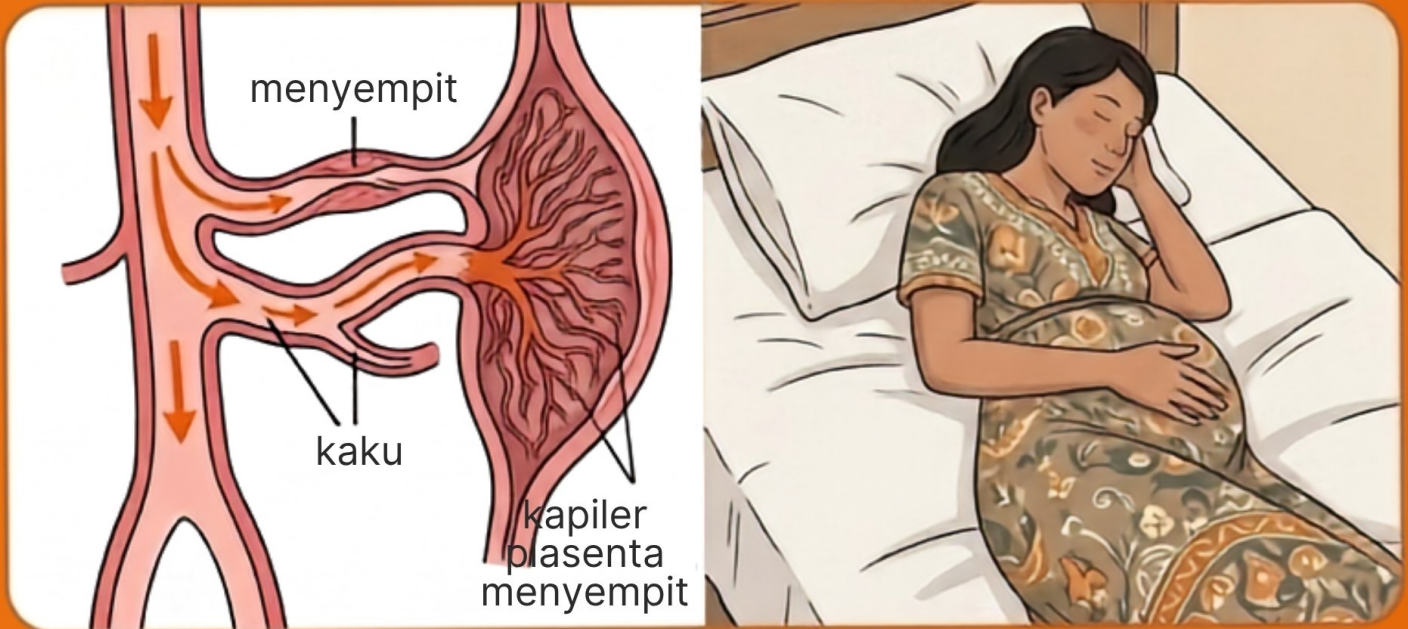
Konsultasi Bidan Puskesmas

Jangan tunggu jadwal bulan depan! Segera temui bidan dalam waktu 1x24 jam untuk evaluasi proteinuria.



Cek Gerak Janin

Pastikan janin bergerak aktif minimal 10 kali dalam 12 jam.



Hipertensi Tahap Awal

Plasenta mulai berisiko mengalami penurunan suplai darah dan nutrisi. Ibu Hamil membutuhkan pemantauan lebih ketat oleh Bidan dan evaluasi faktor risiko preeklamsia di Puskesmas.

Tidur posisi miring ke kiri dapat memperlancar aliran darah dari jantung ke rahim, mengoptimalkan fungsi ginjal, serta membantu menjaga kestabilan tekanan darah pada ibu hamil.

BAHAYA ($\geq 140/\geq 90$ mmHg)



KONDISI KEDARURATAN MEDIS

Ibu berada pada fase preeklamsia nyata yang berisiko memicu **kejang (eklamsia)**, solusio plasenta, atau kelahiran prematur.



Kejang



Solusio plasenta



Prematur bayi

**Ibu harus segera dibawa ke Puskesmas/
Rumah Sakit hari ini juga!**



BAHAYA

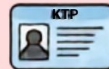
≥ 140 / ≥ 90 mmHg



1. HUBUNGI SUAMI & KELUARGA SIAGA



2. SIAPKAN PERLENGKAPAN



3. SEGERA BERANGKAT
KE IGD TERDEKAT



INGAT!

Penanganan cepat menyelamatkan nyawa Ibu
dan mencegah bayi lahir cacat/stunting!

DARURAT ≥160/110 mmHg



Tekanan darah sangat tinggi ($\geq 160/110$ mmHg).
Risiko sangat tinggi terjadinya kejang (Eklamsia),
stroke, kerusakan organ Ibu, dan gawat janin.

**INI ADALAH KEADAAN GAWAT
DARURAT JANTUNG & KEHAMILAN!**

RUJUK SEGERA



- **Hubungi Ambulans SEKARANG.** Jangan gunakan kendaraan pribadi.
- **Posisikan Ibu Aman:** Berbaring miring kiri.
- **Persiapan MgSO_4 :** Mencegah Kejang.
- **Siapkan Mental:** Persalinan segera.

Bahaya Nifas yang Kerap Terabaikan (KF 1–4)



Masa Nifas Adalah Masa Kritis:



Lebih dari 60% kematian akibat hipertensi kehamilan justru terjadi pada **6 minggu pertama** setelah persalinan.



Bahaya preeklamsia **TIDAK OTOMATIS HILANG** saat bayi lahir.



Pastikan Ibu memenuhi **minimal 4 kali kunjungan nifas (KF)** ke **bidan/dokter** untuk cek tensi, luka persalinan, dan infeksi.

Memahami & Menjaga Kesehatan Jiwa Pascabersalin



Penting untuk Mewaspadaai Gejala Depresi Pascamelahirkan



- Waspadaai perbedaan antara *Baby Blues* (Perasaan Sedih < 2 Minggu) dan **Depresi Pascamelahirkan (PPD)** yang Lebih Serius.

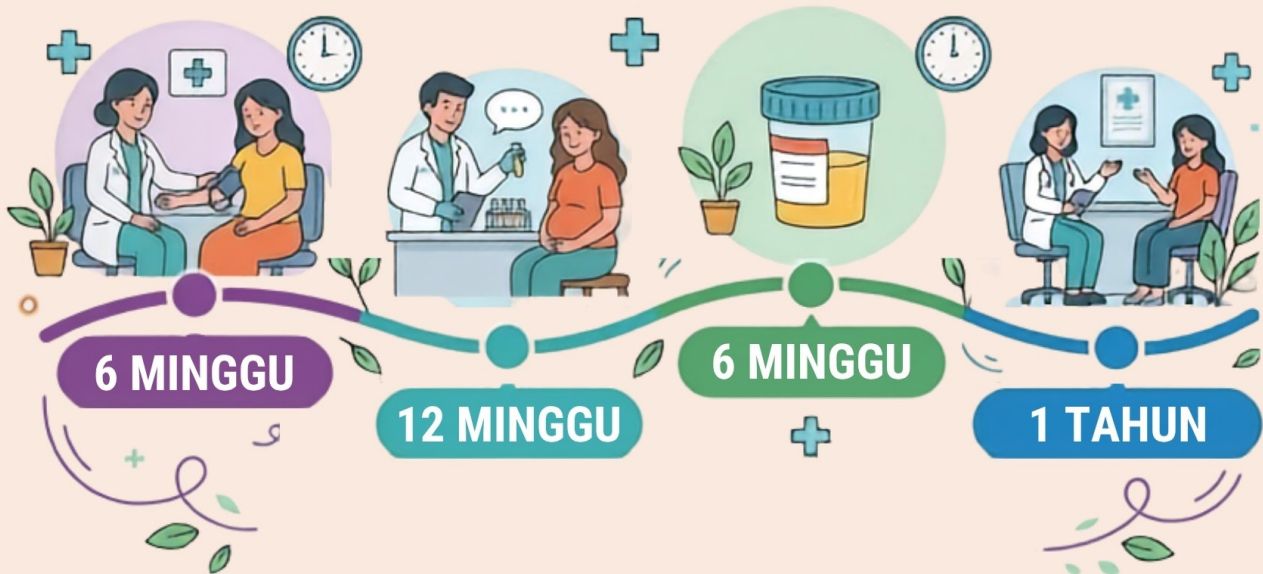


- **Tanda PPD**: Perasaan Sedih Mendalam, Putus Asa, Kehilangan Minat pada Bayi, Kelelahan Ekstrim, Gangguan Tidur.



- Jangan Ragu untuk Mendapatkan **Bantuan Profesional** (Psikolog, Dokter, atau Bidan) Jika Mengalami Gejala.

JADWAL PEMANTAUAN PASCAPERSALINAN



Jadwal Skrining Berkelanjutan:

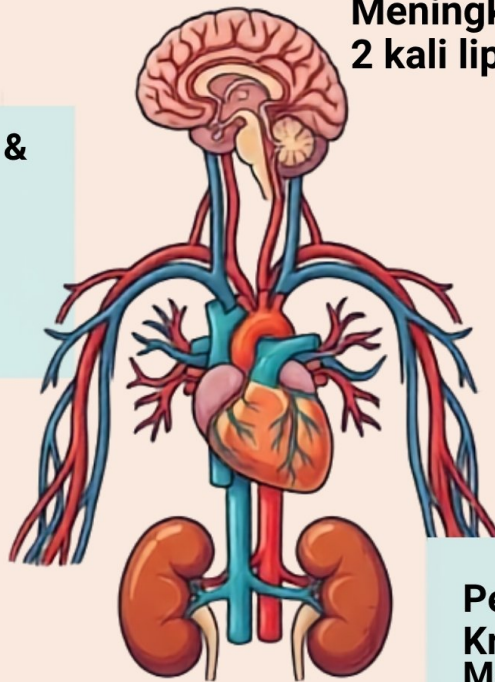
- **Minggu 1 Nifas:** Evaluasi tensi serial oleh bidan di Puskesmas.
- **Bulan ke-3 (6–12 Minggu):** Skrining proteinuria persisten dan fungsi ginjal di laboratorium Puskesmas.
- **Tahun ke-1 Pascasalin:** Skrining komprehensif profil lipid darah, fungsi ginjal, dan kadar gula darah.

MENJAGA JANTUNG & GINJAL SEUMUR HIDUP

Stroke
Meningkat
2 kali lipat **2X**

Gagal Jantung &
Hipertensi

4X
Meningkat
4 kali lipat



Penyakit Ginjal
Kronik (PGK)
Meningkat
4,7 kali lipat **4.7X**

Preeklamsia adalah “sinyal peringatan dini” bahwa sistem kardiovaskular Ibu memerlukan perhatian seumur hidup.

LOGBOOK PEMANTAUAN TENSI ANC

Lembar Catatan Interaktif Hasil Periksa Petugas

No.	Tanggal & Usia Kehamilan (Minggu)	Hasil Pengecekan Tekanan Darah (mmHg)	Status ROTASI	Tanda & Gejala Bahaya (Centang bila ya)	Rencana Tindak Lanjut/ Bidan	Paraf
1		... / ... mmHg		☐ Sakit kepala hebat ☐ Gangguan penglihatan ☐ Nyeri ulu hati akut		
2		... / ... mmHg		☐ Sakit kepala akut ☐ Mual & muntah parah ☐ Sesak napas		
3		... / ... mmHg		☐ Bengkak ekstrem ☐ Urine kurang & pekat ☐ Gerakan janin berkurang		
4		... / ... mmHg		☐ Bengkak ekstrem ☐ Urine kurang & pekat ☐ Gerakan janin berkurang		
5		... / ... mmHg		☐ Sakit kepala hebat ☐ Gangguan penglihatan ☐ Nyeri ulu hati akut		
6		... / ... mmHg		☐ Sakit kepala hebat ☐ Gangguan penglihatan ☐ Nyeri ulu hati akut		
7		... / ... mmHg		☐ Sakit kepala hebat ☐ Gangguan penglihatan ☐ Nyeri ulu hati akut		
8		... / ... mmHg		☐ Bengkak ekstrem ☐ Urine kurang & pekat ☐ Gerakan janin berkurang		
9		... / ... mmHg		☐ Sesak napas ☐ Urine kurang & pekat ☐ Gerakan janin berkurang		
10		... / ... mmHg		☐ Sakit kepala hebat ☐ Gangguan penglihatan ☐ Nyeri ulu hati akut		
11		... / ... mmHg		☐ Bengkak ekstrem ☐ Urine kurang & pekat ☐ Gerakan janin berkurang		
12		... / ... mmHg		☐ Sakit kepala hebat ☐ Urine kurang & pekat ☐ Gerakan janin berkurang		

Continuation >>

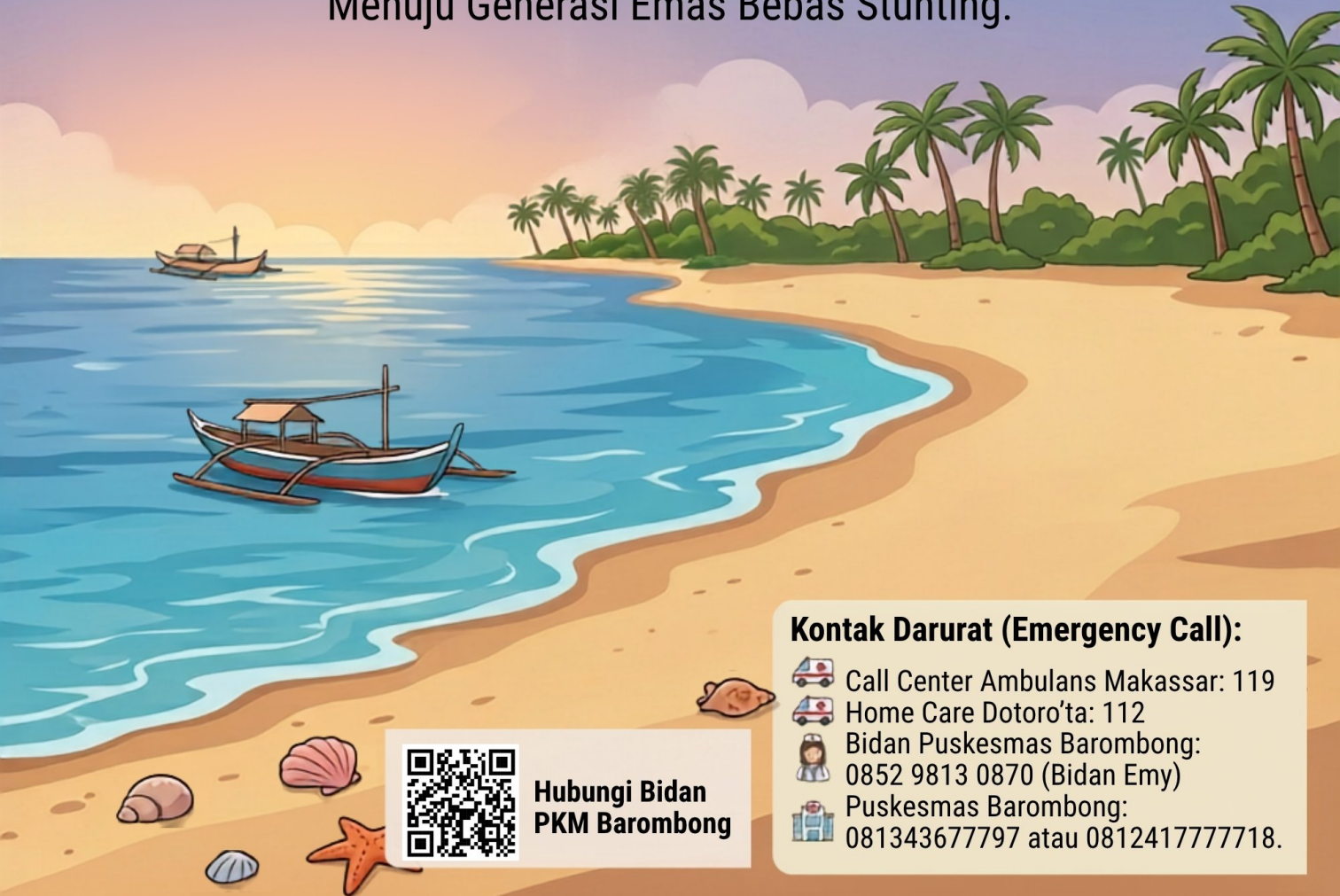
ROTASI             



Puskesmas Barombong

“Kenali warna tekanan darahmu, lindungi dirimu dan buah hatimu.”

**Pencegahan Stunting dari Hulu Kehamilan Pesisir
Menuju Generasi Emas Bebas Stunting.**



Kontak Darurat (Emergency Call):



Call Center Ambulans Makassar: 119



Home Care Dotoro'ta: 112



Bidan Puskesmas Barombong:

0852 9813 0870 (Bidan Emy)



Puskesmas Barombong:

081343677797 atau 0812417777718.



**Hubungi Bidan
PKM Barombong**

Tim Pengusul Riset BIMA 2026: Serli (Ketua Promosi Kesehatan), Sitti Mawaddah Umar, Rasdiana R.
Didanai oleh: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia